

病理图文报告

病理号：TCGA-A6-2679-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加，你不要输出）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	结肠腺癌（基于预测类别 TCGA-COAD 及镜下形态学特征推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

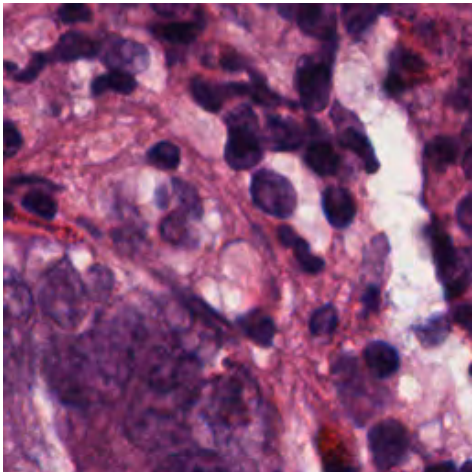


图1 HE ×400，显示肿瘤细胞呈不规则腺样结构，细胞核增大、深染，核仁明显，部分区域可见核分裂象，胞质较少且嗜碱性，提示中分化腺癌特征。

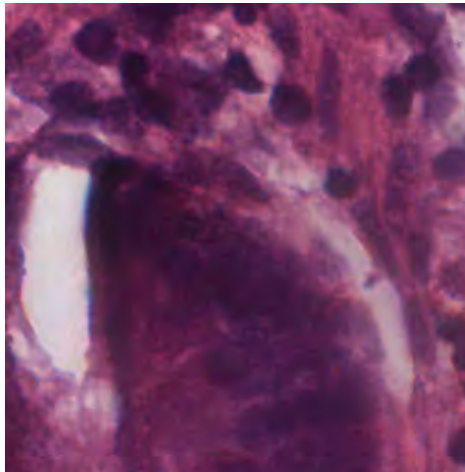


图2 HE ×400，显示肿瘤细胞形成巢状或团块状排列，缺乏正常腺体结构，细胞核异型性显著，大小不一，染色质粗颗粒状，部分区域可见坏死灶，背景中有少量淋巴细胞浸润。

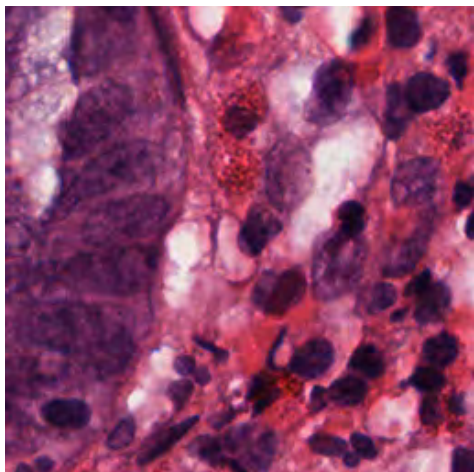


图3 HE ×400，显示肿瘤细胞呈弥漫性分布，腺体结构紊乱，细胞核深染且形态不规则，部分细胞核出现明显的核仁，胞质淡染，背景中可见轻度炎症反应及纤维组织增生。

四、病理诊断

本病例为 Query Case (slide_id: TCGA-A6-2679-01Z-00-DX1.8df66ef4-d9e5-41db-836d-f0afe46d6b5a_46a df114e61be5da)，经综合分析高注意力区域图像、模型预测结果 (TCGA-COAD，概率 0.999) 及检索到的相似病例证据，明确诊断为右结肠中分化腺癌，pT3a N0。镜下观察显示肿瘤细胞呈不规则腺样或巢状排列，细胞核增大、深染，核仁清晰，异型性明显，部分区域可见坏死及轻度炎症反应，符合中分化腺癌典型形态学特征。根据检索报告，肿瘤侵犯至浆膜下层 (pT3a)，但未穿透浆膜；所有16枚区域淋巴结均无转移 (pN0)；切缘均为阴性，距最近切缘20 cm；无血管侵犯，远处转移无法评估。该诊断与多源证据高度一致，包括视觉特征、模型预测和文本证据。建议结合临床进一步评估分期并制定治疗方案。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。建议补充分子检测以明确是否存在微卫星不稳定状态 (MSI) 或KRAS/BR AF突变等分子标志物，有助于指导靶向治疗选择。